

Sclérodermie systémique

Dr L. Idir

Service de Médecine Interne

Objectifs

- Définir une sclérodermie systémique
- Différencier une sclérodermie systémique d'une sclérose cutanée et des états sclérodermiiformes
- Identifier les situations d'urgences
- Préciser les principes du traitement et la stratégie de suivi

Introduction/ Définition

- Sclérodermies: affections ayant en commun une sclérose cutanée.
- Sclérodermie systémique: s'accompagne souvent de manifestations viscérales pouvant mettre en jeu le pronostic vital
- Il s'agit d'une connectivite rare
- Plus fréquente chez la femme (3 femmes pour 1 homme)
- Age de début: 40 à 50 ans le plus souvent

Physiopathologie

- Anomalies du tissu conjonctif: accumulation de la matrice extracellulaire avec excès de fibres collagènes (fibrose tissulaire et vasculaire);
- Atteinte micro vasculaire oblitérante
- Désordres immunologiques
- Facteurs de risques parfois retrouvés: silice, solvants

Clinique/ paraclinique

- **Phénomène de Raynaud:** 90 à 95% des cas

Souvent inaugure la maladie ++++

- Sévère ++++ avec des complications à type d'ischémie et d'ulcérations+/- surinfection
- Peut toucher toutes les extrémités (mains, pieds lèvres , nez, oreilles)



EMC dermatologie/ Sclérodémie systémique
98-505-A-10

EMC : traité de médecine Akos
sclérodémie Systémique/ 5-0300



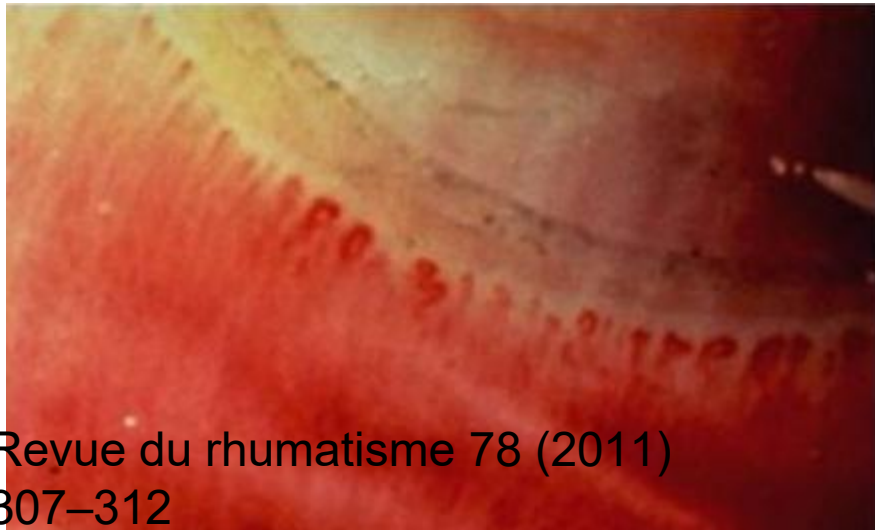
EMC : traité de médecine Akos/
sclérodémie Systémique/ 5-0300

EMC angéiologie/ sclérodémie
systémique / 19-0660



- Capillaroscopie :

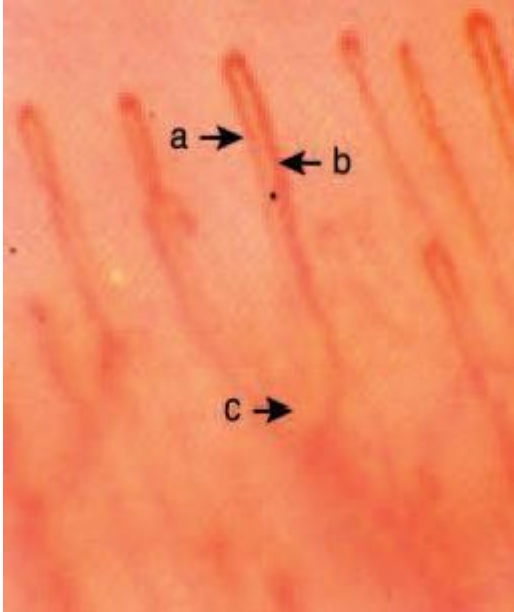
Présence de méga-capillaires, raréfaction des capillaires, hémorragies sous unguéales



Revue du rhumatisme 78 (2011)
307-312



EMC : traité de médecine Akos/ sclérodémie
Systémique/ 5-0300



- **Manifestations cutanées:**

- Fibrose et épaissement cutané:

- Extrémités+++, bilatérale et symétrique.

Puis tend à s'étendre vers les zones proximales en fonction de la forme clinique.

- Impossibilité de la pincer entre le pouce et l'index

- Rétraction des doigts en flexion

- Limitation de l'extension des coudes

- Appréciee par le score de **Rodnan**:(utile pour le suivi)





EMC-Rhumatologie Orthopédie 2 (2005)
479–500

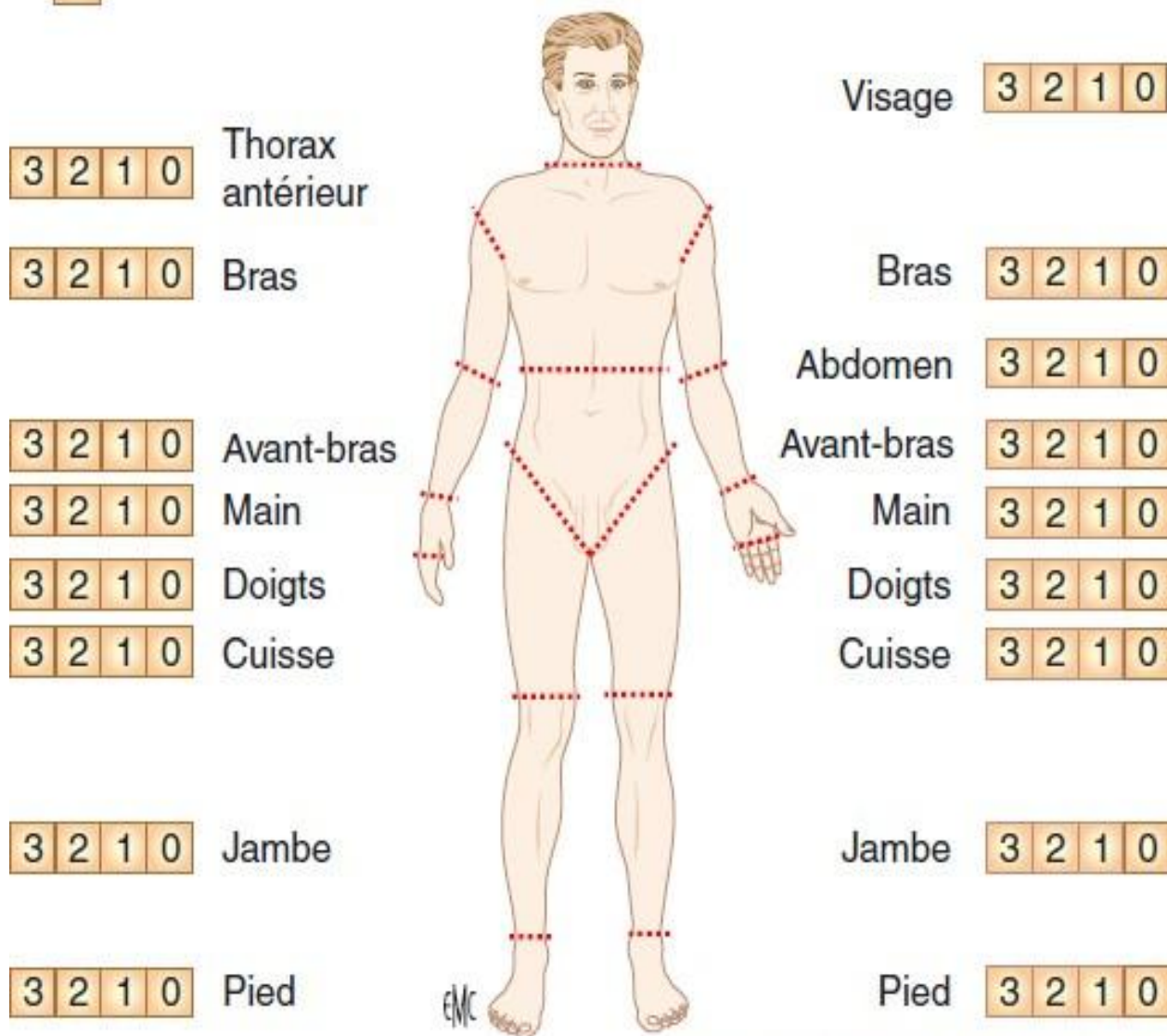
A

- Limitation d'ouverture de la bouche (distance inter incisives)
- Amincissement des lèvres
- Nez effilé
- Plis radiés en péri-buccaux



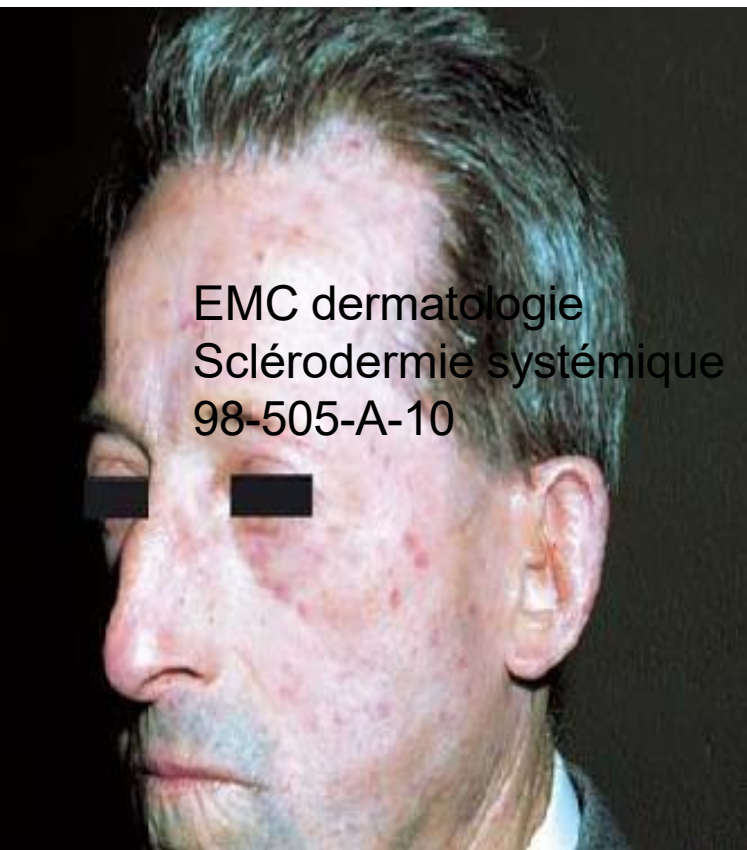
EMC dermatologie/ Sclérodémie systémique/98-505-A-10

- 3 Sclérose adhérente au plan profond
- 2 Sclérose intermédiaire
- 1 Sclérose superficielle
- 0 Absence de sclérose



Score maximum (17 sites) : 51

- Télangiectasies: visage , décolleté et mains.
- Calcinose sous cutanée : zones de traumatisme, face d'extension des articulations





EMC angéiologie/ sclérodermie systémique / 19-0660

- **Manifestations ostéo-articulaires:** arthralgies, raideur, rarement arthrites , les déformations des mains sont en rapport avec la rétraction des doigts liée à la sclérose cutanée.
- **Manifestations musculaires:** myalgie, ou véritable myosite . Plus souvent dans les formes diffuses.

- **Manifestations digestives**:++++++ (75 à 90%)

Œsophage: hypomotilité et hypotonie du sphincter inférieur de l'œsophage (manométrie œsophagienne) responsable d'un reflux gastro-œsophagien

Pyrosis +/- dysphagie.

Complications: œsophagite peptique, endobrachy-œsophage voir adénocarcinome (FOGD)

Estomac : gastroparésie

Dyspepsie, nausées, vomissements

Intestin grêle : sd pseudo-occlusif, diarrhée, malabsorption; (dénutrition et cachexie)

Colon: sd pseudo-occlusif, ballonnement, constipation, douleurs abdominales.

Anus et rectum: incontinence anale, prolapsus rectal

- **Pneumopathie interstitielle diffuse: mauvais pronostic.**

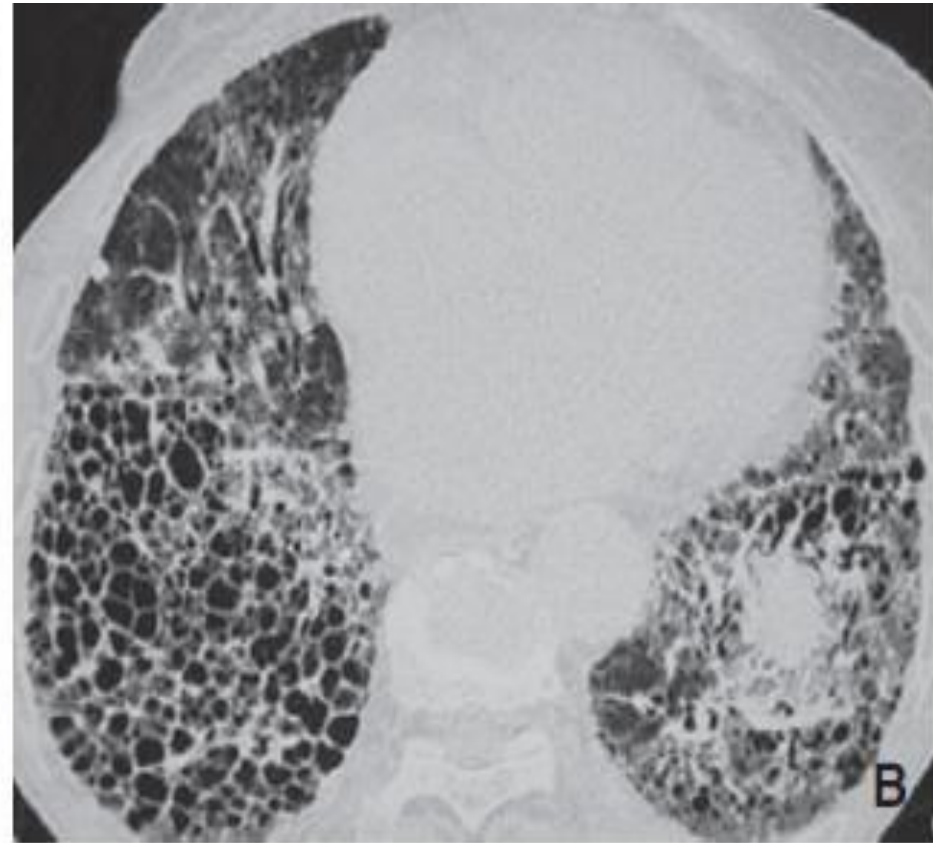
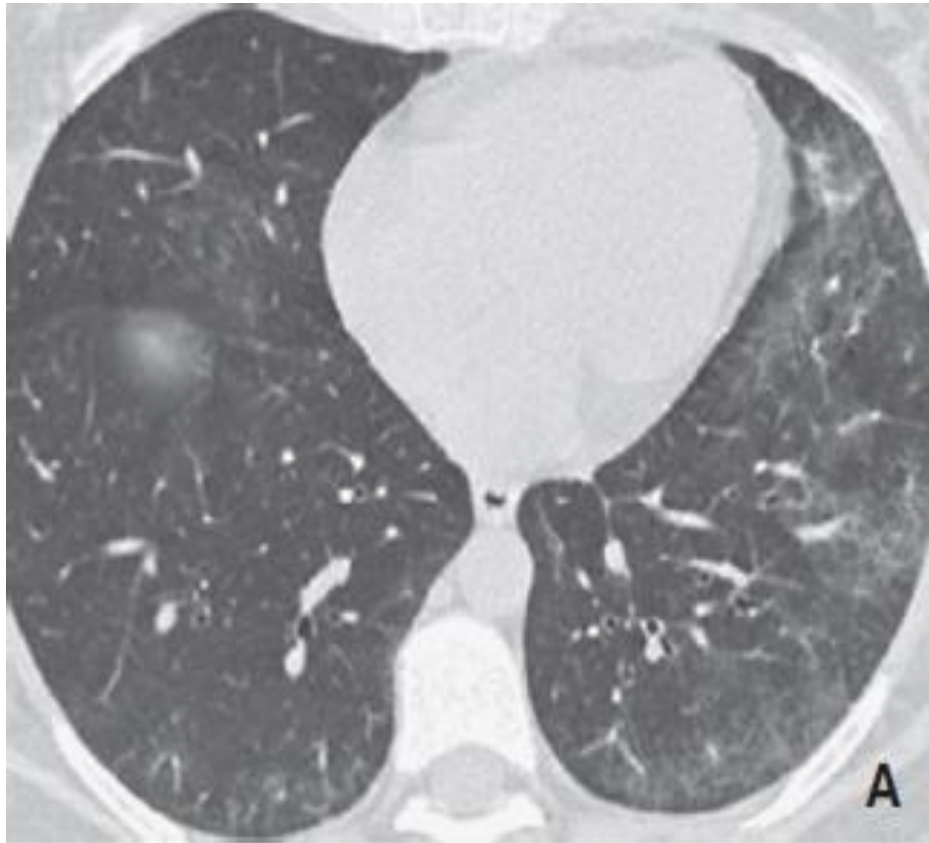
Clinique: dyspnée d'effort d'aggravation progressive

Crépitant aux bases, toux sèche.

Rx poumon: normale ou opacités réticulaires

TDM thoracique HR++: opacités en verre dépoli ou en rayon de miel.

EFR: sd restrictif



EMC angéiologie/ sclérodermie systémique / 19-0660

- **Hypertension artérielle pulmonaire:**

Mauvais pronostic; cause de décès.

Clinique: asymptomatique ou

- Dyspnée d'effort d'aggravation progressive inexpliquée par une atteinte cardiaque ou parenchymateuse
- Signes d'insuffisance cardiaque droite.
- Syncope ; hémoptysie

Echodoppler cardiaque:+++ dépistage annuel et en cas de dyspnée

- **Manifestations cardiaques:** fréquentes mais souvent asymptomatique.

Atteinte de la microcirculation coronarienne

- Dysfonction du VG +/-dysfonction du VD
- Péricardite de petite abondance, rarement temponnade
- Troubles du rythme et troubles de la conduction avec possibilité de mort subite

ECG, échodoppler , IRM cardiaque

- **Crise rénale sclérodermique: 4% des cas**

Pourrait être favorisée par une corticothérapie, elle est liée à l'atteinte des artérioles rénales

HTA sévère et/ou insuffisance rénale rapidement progressive oligo-anurique avec schizocytes au frottis sanguin (hémolyse)

Mortalité élevée: jusqu'à 50% à 5 ans

Intérêt de la surveillance régulière de la TA et de la créatininémie

Formes cliniques

- CREST syndrome: calcinose- Raynaud- atteinte œsophagienne- sclérodactylie -télangiectasies (meilleur pronostic)
- Forme diffuse: sclérose proximale, avec atteintes viscérales (mauvais pronostic)
- Forme limitée: la sclérose cutanée est distales ne dépassant pas les coudes , ni les genoux . Les manifestations viscérales sans rares. HTAP possible au cours de l'évolution.

- Formes associées:

Cirrhose biliaire primitive (sd de Reynolds)

Le sd de Gougerot- Sjogren

Les autres connectivites

Silicose (sd d' Erasmus)

Auto-anticorps

- Ac antinucléaires: 90%
- Anticorps anti-centromères dans les formes limitées
- Anticorps anti-topo-isomérase I ou anti- scl70 (F diffuses)
- Anticorps anti-polymérase III dans les formes avec atteinte rénale

Critères de classification 2013^a de l'American College of Rheumatology/European League against Rheumatism pour la sclérodermie systémique^[2].

Item	Sous-item	Score
Sclérose cutanée des doigts s'étendant au-delà des articulations métacarpophalangiennes (critère suffisant)		9
Épaississement des doigts (seul compte le score le plus élevé)	Doigts boudinés	2
	Sclérodactylie	4
Lésions digitales distales (seul compte le score le plus élevé)	Ulcération digitale	2
	Cicatrices pulpaire	2
Télangiectasies		2
Anomalies à la capillaroscopie		2
Atteinte interstitielle pulmonaire ou hypertension artérielle pulmonaire (score maximal = 2)	Atteinte interstitielle pulmonaire	2
	Hypertension artérielle pulmonaire	2
Phénomène de Raynaud		3
Autoanticorps en rapport avec la ScS (score maximal = 3)	Anticentromère	3
	Anti-topo-isomérase I	
	Anti-ARN polymérase III	

ScS : sclérodermie systémique ; ARN : acide ribonucléique.

^a Ces critères sont applicables à tout patient pouvant être inclus dans une étude sur la ScS. Ils ne sont pas applicables à des patients qui ont des épaississements cutanés épargnant les doigts ou à des patients ayant une pseudosclérodermie pouvant mieux expliquer leurs manifestations (par exemple fibrose néphrogénique, morphee généralisée, fasciite à éosinophiles, sclérose diabétique, scléromyxœdème, érythromyalgie, porphyrie, lichen scléreux, réaction du greffon contre l'hôte, chéiroarthropathie diabétique). Le score total est déterminé par l'addition des scores maximaux dans chaque catégorie. Les patients totalisant un score supérieur à 9 sont classés comme ayant une ScS.

Diagnostic différentiel

- **Sd sclérodémiformes:**

Réaction du greffon contre l'hôte

Fasciite à éosinophiles (Shulman)

Chéiroarthropathie diabétique: (sclérodactylie piégeante)

Sd de Werner: vieillissement précoce

Sd sclérodermique paranéoplasique

- **Sclérodermie localisée:** les Morphées

Principes du traitement

Prise en charge

- Traitements symptomatiques+++
- Traitement immunosuppresseur en cas de scl diffuse de diagnostic récent (3 à 5 ans) et/ou PID évolutive
- Le but est de soulager, d'améliorer la qualité de vie et d'éviter au maximum les complications.

- **Phénomène de Raynaud:**

Protection contre le froid, éviction des produits corrosifs, éviter les B bloquants, et les vasoconstricteurs, éviter le tabac

Inhibiteurs calciques

Antagonistes des récepteurs de l'endothéline

- **Sclérose cutanée:**

Kinesithérapie+++

Immunosuppresseurs dans les formes aiguës
rapidement progressives

- **HTAP:** antagoniste des récepteurs de l'endothéline
- **Pneumopathie interstitielle évolutive:**
immunosuppresseurs
- **RGO:** règles hygiéno-dietétiques / inhibiteurs de la pompe à proton, prokinétiques
- **Crise rénale:** IEC , voir hémodialyse